

Fecha Última Actualización: 04-11-2022 10:38:53

Página 1 de 3

### Información Paciente

**Nombre** : Rosa Reyes Morales

**Edad** : 64a 7m 5d

**Dirección** : El Fruto Poniente Block1714 Dp 202

**Rut** : 7.734.798-4

**Fecha Nacto**: 30/03/1958

**Comuna** : Puente Alto

**N° Archivo** : A243684

**Sexo** : Femenino

**Teléfono** : 9 9671 4744

N° Epicrisis

**329031**

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Ingreso** : 29/09/2022 02:00

**Días Estadía**: 36

**Unidad de Egreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Egreso** : 04/11/2022 10:11

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Colangitis

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

EPICRISIS

Rosa Reyes Morales.

7.734.798-4.

Ingreso CASR: 28/09/22.

Ingreso UTAC: 30/09/22.

Ingreso RECUCI: 01/10/22.

Ingreso a UPC: 04/10/22

Antecedentes mórbidos:

·Colecistectomía

·Cesárea

·Consumo de alcohol, niega tabaco y otras drogas

·Niega alergias

Medicación habitual

·Ninguna

Historia clínica

Pacientes con antecedentes descritos, inicia cuadro clínico el 23/09/2022 caracterizado por epigastralgia urente, astenia, adinamia, edema de miembros inferiores y disnea, el 27/09/2022 suma ictericia, aumento e perímetro abdominal y desorientación, en ese contexto consulta el 28/09/2022 al servicio de urgencias de esta institución, en donde ingresa taquicárdica (120 latidos por minuto), T 37.4°C, normotensa, saturando 96 % con FiO2 21%; al laboratorio destaca lactato 38.8, bilirrubina total 13.9 (directa 8.8), GOT 52, GPT 28, GGT 407, FA 214. PCR 239, leucocitos 19870, INR 1.76, se realiza TC de tórax (angioTC), abdomen y pelvis que informa:

·Examen sin signos de tromboembolismo pulmonar hasta nivel segmentario.

·Coledocolitiasis a nivel del colédoco intrapancreático que determina moderada dilatación de la vía biliar extrahepática.

·Signos de íleo colitis derecha, de probable etiología inflamatoria - Infecciosa.

·Leve a moderada ascitis difusa.

**Fecha Epicrisis : 04/11/2022 10:38**

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 04-11-2022 10:38:53

Página 2 de 3

Se complementa con ecografía abdominal que informa: Cambios morfológicos de daño hepático crónico con ascitis y esplenomegalia como marcador de hipertensión portal. Dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, sin identificar factor obstructivo.

Evoluciona con mala mecánica ventilatoria e inestabilidad hemodinámica, requiere intubación orotraqueal, e ingresa a pabellón para ERCP en donde según protocolo operatorio:

- Se avanza hasta la 2 porción duodenal. Papila con poro erosionado y muy abierto; no se canula ni contrasta el Wirsung.
- Colangiografía: Vía biliar dilatada sin defectos de llenado, se canula vía biliar con papilotomo de asa sobre guía
- Papilotomía. Revisión con Balón da salida a barro biliar.
- Papilotomía queda con sangrado persistente por lo que se realiza inyecta terapia con adrenalina 1:20.000 logrando buena hemostasia.

Ingresa a recuperación anestésica en el postoperatorio inmediato.

Se realiza paracentesis diagnóstica que es compatible con peritonitis bacteriana espontánea.

Evoluciona con falla hemodinámica progresiva, falla respiratoria con empeoramiento de intercambio gaseoso en la fecha con PaFi alrededor de 140, requiere sedación profunda y relajación neuromuscular, falla renal, recibió diuréticos de asa y espironolactona, cubierta con ampicilina sulbactam empírica en contexto de posible aspiración, sin cultivos además del líquido peritoneal.

El 03/10/2022 Se realiza TC de abdomen y pelvis que informa:

- Signos de daño hepático crónico con moderada ascitis y formación de circulación colateral porto sistémica como marcadores de hipertensión portal.
- No se demostraron imágenes sugerentes de hepatocarcinoma ni lesiones sugerentes de abscesos en el parénquima hepático.
- Resolución de la dilatación de la vía biliar intrahepática.
- Ectasia la vía biliar extrahepática que se asocia a leve engrosamiento e hiper realce de aspecto inflamatorio de la vía biliar.
- Signos de colitis derecha, el diagnóstico diferencial considerar colopatía portal.
- Leve derrame pleural bilateral.

En ese contexto ingresa a UCI. bajo sedoanalgesia hasta RASS -5, pupilas mióticas, isocóricas, hiporreactivas, intubada, conectada a ventilación mecánica, hipoventilación en ambas bases pulmonares a predominio derecho, abdomen globuloso, distendido, blando, R1 y R2 normo fonéticos, extremidades simétricas.

Se realiza Ecoscopia, corazón impresiona con contractibilidad conservada, sin segmentariedad, VCI sin variabilidad, VI mayor que VD, en pulmón líneas B 4 y 5 por campo, derrame pleural derecho 4 cm de despegamiento, derrame pleural izquierdo escaso, abdomen líquido libre compatible con ascitis conocida, no se aprecia globo vesical.

Rx de tórax, derrame pleural derecho, no impresionan opacidades en campos pulmonares.

### Evolución en UCI

Ingresa grave, con disfunción circulatoria severa en contexto de sepsis de foco no precisado, con falla respiratoria severa que requiere manejo con sedación profunda y relajación neuromuscular con buena respuesta, con falla hepática aguda sobre crónica y falla renal inicial. Se maneja con antibióticos empíricos con Vancomicina/Imipenem, se pancultiva destacando PBE por K Oxytoca por lo que completa tratamiento con Imipenem. Colangitis con descompresión de vía biliar el 01/10/2022 con control de imágenes que confirma resolución de dilatación de la vía biliar intrahepática. Cursa con falla renal en incremento que requiere de inicio de terapia de reemplazo renal, con Sd compartimental que requiere de BNM con buena respuesta. Evoluciona hacia la estabilidad por lo que se inicia despertar y weaning. Destaca con encefalopatía hepática severa, con coagulopatía por lo que fue evaluada por Cx HPB quienes indican que es candidata a Tx hepático por lo que se enlista. Se realiza THO el día 28/10/22. Cirugía compleja con shock hemorrágico 2río que requirió de Tx masiva, 2 PCR intraoperatorios. Requerimiento de Packing abdominal por hemostasia dificultosa.

Ingresa a UCI en shock refractario con Nora/Adrenalina/Vasopresina por lo que se realiza HFAV por 24 hrs con buena respuesta y luego HDFVVC por 48 hrs. Injerto con mala función inicial que revierte después de estabilidad HDN.

Ingresa a cirugía para retiro de Packing 02/11/22 donde se evidencia necrosis masiva de intestino delgado y grueso, por lo que se realiza resección intestinal masiva y retiro de Packing. Sale a UCI en regulares condiciones, se informa a familia de pronóstico ominoso evolucionando con progresión de la disfunción HDN falleciendo el 04/11/22 a las 10:18 hrs.

### Diagnóstico de Egreso

Shock séptico - Isquemia mesentérica - Colangitis

Fecha Epicrisis : 04/11/2022 10:38

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:06

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



# Epicrisis Hospitalaria

**ESTADO: DEFINITIVA**



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 04-11-2022 10:38:53

Página 3 de 3

**Condición de Egreso** Fallecido

Se confecciona certificado de defunción

Egreso con Catéter Doble J:NO

## Plan Post Alta

Anatomía patológica

## Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

## Controles

INTERNO

Romyna Baghetti Hernan

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 04/11/2022 10:38

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:06

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar